Revista de Enfermagem UFPE On Line

ISSN: 1981-8963

ARTIGO ORIGINAL

PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE MENTAL SOBRE O TRABALHO MULTIPROFISSIONAL COM RESIDENTES

PERCEPTION OF MENTAL HEALTH PROFESSIONALS ABOUT THE MULTIPROFESSIONAL WORK WITH RESIDENTS

PERCEPCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD MENTAL EN EL TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO CON LOS RESIDENTES

Giovana Telles Jafelice[1], João Fernando Marcolan[2]

RESUMO

Objetivo: verificar como profissionais de Saúde Mental compreendiam multi, inter e transprofissionalidade, ocorrência na prática e influências para os residentes. ***Método:*** estudo exploratório, descritivo, de abordagem qualitativa. A amostra foi composta pelo coordenador e pelo menos dois profissionais com diferentes formações em cada serviço. O instrumento de coleta foi composto por quatro questões norteadoras. Os dados foram analisados pela técnica de Análise de Conteúdo. ***Resultados:*** os participantes não souberam definir trabalho em equipe multiprofissional, interprofissional e transprofissional em Saúde Mental; não houve trabalho em equipe multiprofissional, interprofissional e transprofissional nas unidades e o Programa não oferecia condições para inserção no sistema de saúde nem formação para tal. ***Conclusão:*** observaram-se dificuldades na conceituação das modalidades de integração disciplinar. Elencaram-se elementos facilitadores e dificultadores destas ações. Discutiu-se a importância das Residências Multiprofissionais na formação em saúde e da aproximação efetiva das Políticas Públicas de Saúde. ***Descritores:*** Saúde Mental; Abordagem de Tratamento Interdisciplinar; Políticas Públicas.

ABSTRACT

Objective: to verify how Mental Health professionals understood multi, inter and transprofessionality, occurrence in practice and influences for residents. ***Method:*** exploratory, descriptive study, with qualitative approach. The sample consisted of the coordinator and at least two professionals with different graduations at each service. The collection instrument consisted of four guiding questions. Data were analyzed using the Content Analysis technique. ***Results:*** the participants did not know how to define multiprofessional, interprofessional and transprofessional work in Mental Health; there was no work in a multiprofessional, interprofessional and transprofessional team at the units and the Program did not offer conditions for insertion in the health system nor training for such. ***Conclusion:*** there were difficulties in the conceptualization of disciplinary integration modalities. Facilitating and hindering elements of those actions were listed. The importance of Multiprofessional Residences in health training and the effective approximation of Public Health Policies were discussed. ***Descriptors:*** Mental Health; Interdisciplinary Treatment Approach; Public Policies.

RESUMEN

Objetivo: verificar cómo los profesionales de la salud mental comprenden multi, inter y transprofissionalidad, su producción en la práctica y las influencias para los residentes. ***Método:*** estudio exploratorio, descriptivo, con enfoque cualitativo. La muestra estuvo compuesta por el coordinador y al menos dos profesionales con diferentes formaciones en cada servicio. El instrumento consistió en cuatro preguntas de orientación. Los datos fueron analizados por la técnica de Análisis de Contenido. ***Resultados:*** los participantes no sabían cómo definir el trabajo en equipo multidisciplinario, interprofesional y transprofesional en Salud Mental; no había trabajo en equipo multidisciplinario, interprofesional y transprofesional en las unidades y el programa no ofrecía las condiciones para su inclusión en el sistema de salud o la formación para hacerlo. ***Conclusión:*** fueron observadas dificultades en la conceptualización de las modalidades de integración disciplinaria. Fueron listados facilitadores y dificultadores de estas acciones. Fueron discutidas la importancia de residencias multidisciplinares en la formación en salud y un enfoque efectivo de Políticas Públicas de Salud. ***Descriptores:*** Salud Mental; Abordaje de Tratamiento Multidisciplinario; Políticas Públicas.

[1]Psicóloga, Residência Multiprofissional em Saúde Mental, Mestranda em Ciências da Saúde , Escola Paulista de Enfermagem, Universidade Federal de São Paulo/EPE/UNIFESP). São Paulo (SP), Brasil. gi_jafelice@yahoo.com.br; [2]Enfermeiro, Professor Doutor em Enfermagem, Escola Paulista de Enfermagem, Universidade Federal de São Paulo/EPE/UNIFESP). São Paulo (SP), Brasil. E-mail: jfmarcolan@uol.com.br

INTRODUÇÃO

O Paradigma da Produção Social da Saúde destaca o trabalho interdisciplinar em saúde, realizado por equipes multiprofissionais. Este é exigência do modelo atual de promoção de saúde no SUS, pois sua definição é interdisciplinar.[1]

A Reforma Psiquiátrica introduziu novo paradigma, da Atenção Psicossocial, que propõe diferentes formas de lidar com a loucura e a abordagem mais ampla de cuidado com a saúde. A interdisciplinaridade passou a ser evocada, pois o objeto de trabalho da Saúde Mental envolve de forma concomitante as relações sociais, as expressões emocionais, de afeto e biológicas, a exigir pensamento complexo.[1]

O conceito de interdisciplinaridade pode ser abordado em relação com outros termos, como multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. Apesar das divergências no entendimento destas interações possíveis, conceitua-se a disciplinaridade como área homogênea de estudo, com fronteiras bem delimitadas, que não pode ser pensada sem considerar as relações de poder que se colocam como forma de controle da produção do discurso.[2]

A multidisciplinaridade propõe a justaposição de diversas disciplinas, sem necessariamente implicar em trabalho conjunto e coordenação.[3] A interdisciplinaridade é ligada às noções de integralidade do cuidado e à produção conjunta de uma disciplina modificada. É mais do que a tomada de elementos de outras disciplinas, mas a incorporação destes num novo modo de pensar, a combinação de disciplinas, a provocar transformações recíprocas em cada uma.[4] A transdisciplinaridade vai ainda mais além, não se restringe à interação e reciprocidade, mas propõe a ausência de fronteiras,[3] abertura ao que atravessa e ultrapassa as disciplinas, sem dizer respeito ao domínio de umas sobre as outras.[5]

Observam-se obstáculos à interdisciplinaridade em equipes de Saúde Mental devido a forte tradição positivista e biocêntrica no tratamento, os espaços de poder da disciplinarização e a estrutura das instituições de ensino. [1]

O modelo tradicional de atenção à saúde, estruturado a partir do saber médico e de interesses corporativos, ainda influencia a organização das equipes e contribui para a fragilização das relações e ao trabalho multiprofissional integrado. [1] A concepção multiprofissional parte de pressuposto distinto a exigir dos profissionais a utilização de saberes singulares, construídos a partir de lógicas diferentes, de forma compartilhada [6].

A formação de profissionais em serviço é importante e necessária, pois as novas modalidades de Atenção em Saúde Mental incluem diferente forma de se relacionar com a loucura sob a ética da inclusão, e ao se ter que as instituições de formação não assimilaram as discussões colocadas pela Reforma Psiquiátrica e contribuem pouco para sua avaliação e desenvolvimento.[7]

Dentre as atribuições da União está a participação na política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a Saúde.[8] Neste contexto, se desenvolveram os programas de Residência Multiprofissional que têm como eixos norteadores: a concepção ampliada de saúde; estratégias pedagógicas promotoras de aprendizagem de formação integral e interdisciplinar; integração de saberes e práticas construtoras de competências compartilhadas; articulação da Residência Multiprofissional e Médica e a integralidade.[9]

Buscam-se conectar os conhecimentos adquiridos na graduação com a complexidade dos determinantes que se inter-relacionam na prática dos serviços e são alternativas de promoção de mudanças na prática assistencial em saúde, a favorecer o trabalho em equipe, as trocas profundas de saberes e ações e nova realidade de saúde para os usuários.[10] Objetivam a transformação dos serviços de saúde formadores, que podem ser incentivados a refletir sobre as práticas que desenvolvem e suas possibilidades e limitações para reconfigurá-las.[10]

O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental da Universidade Federal de São Paulo existe desde o ano de 2011. Como parte da carga horária de atividades práticas, os residentes são divididos em equipes multiprofissionais que se revezam em diferentes serviços, a atuar com as equipes dos equipamentos.

A autora deste estudo fez parte dos residentes ingressantes em 2013 e realizou estágio em seis serviços. A partir das vivências, observamos que o trabalho multiprofissional ocorria de modo incipiente em muitos dos serviços formadores. Se considerarmos que muitos foram, e ainda são, geridos por profissionais médicos, da separação entre Residência Médica e Multiprofissional, vimos que a prática se encontrava mais próxima das ideias de interdisciplinaridade auxiliar[1,3] e equipe agrupamento [11] do que da construção conjunta de saberes e planos terapêuticos.

OBJETIVO

● Verificar como profissionais de Saúde Mental compreendiam multi, inter e transprofissionalidade, ocorrência na prática e influências para os residentes.

MÉTODO

Estudo exploratório, descritivo, de abordagem qualitativa.[12] Foi realizado em três campos de prática da Residência Multiprofissional em Saúde Mental da UNIFESP em 2013: Centro de Convivência e Cooperativa (CECCO), da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (SP), Brasil. Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e ambulatório de atenção a crianças e adolescentes, ambos do Departamento de Psiquiatria da UNIFESP.

Foram entrevistados profissionais de nível superior, membros da equipe fixa dos serviços. A amostra foi definida por conveniência e composta por uma pessoa da coordenação e pelo menos dois profissionais de diferentes formações, prestadores de assistência em cada serviço. Critérios de inclusão: estar no mínimo um ano no equipamento e ter participado das atividades junto aos residentes.

As entrevistas foram realizadas a partir de questões norteadoras, com gravação em áudio e transcrição para processamento e análise dos dados. O instrumento de coleta de dados foi elaborado pelos pesquisadores, teve dados do participante e as questões norteadoras: O que você entende por trabalho em equipe multiprofissional em Saúde Mental? Você considera que há trabalho em equipe multiprofissional no serviço em que atua? Qual o maior desafio do trabalho em equipe multiprofissional na sua unidade? Como você percebe a participação dos residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental neste campo? Qual a sua percepção do trabalho multiprofissional dos profissionais da unidade junto aos residentes?

O processamento e análise de dados se deram a partir dos pressupostos da Análise de Conteúdo. Foram realizadas três fases: pré-análise; exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Por conveniência dos pesquisadores não foi realizada análise quantitativa.[12]

As entrevistas foram transcritas sem omissão de dados e nas transcrições foram subtraídos os maneirismos de linguagem da pesquisadora e dos entrevistados. Com os dados categorizados, foram relacionados ao marco teórico, de modo que tal simbiose pôde dar sentido à interpretação.[12]

O projeto de pesquisa recebeu parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP sob Nº CAAE 647.539/2014.

RESULTADOS

Foram entrevistados 11 profissionais durante os meses de junho e julho de 2014, sendo quatro do CECCO, quatro do CAPS e três do ambulatório. Participaram uma enfermeira, três médicos, duas terapeutas ocupacionais, duas assistentes sociais, duas psicólogas e uma cientista social. Para preservar a identidade, não se discriminou quais profissionais pertenciam a cada equipamento.

As idades dos entrevistados variaram de 31 a 63 anos, com média de 45 anos. O tempo de trabalho na unidade de Saúde variou de 1 a 16 anos, sendo a média de 7 anos. Quanto ao tempo de graduação, houve variação de 7 a 39 anos e média de 21 anos.

Foram elaboradas três categorias, que serão descritas a seguir.

♦♦ Categoria 1 - Definição de trabalho em equipe multiprofissional, interprofissional e transprofissional em Saúde Mental

Alguns entrevistados se aproximaram dos conceitos de trabalho em equipe multi, inter e transprofissional; outros não sabiam a respeito e arriscaram a resposta e um terceiro grupo admitiu não saber e não respondeu.

♦ Trabalho em equipe multiprofissional em Saúde Mental

Dez profissionais se aproximaram do conceito de trabalho em equipe multiprofissional em Saúde Mental. A maioria destacou a contribuição dos diversos olhares e formações profissionais nesta modalidade:

> *Equipe de várias profissões. Trabalho com um objetivo comum, mantendo a especificidade e o olhar particular de cada profissão. O multi [...] é mais compartimentalizado [...] cada profissional exerce a sua prática [...] ainda muito específico. [...] Ainda não existe [...] esse compartilhamento, esse entrelaçamento dos saberes. (E6)*

♦ Trabalho em equipe interprofissional em Saúde Mental

Seis profissionais se aproximaram do conceito de trabalho em equipe interprofissional. Destacaram a troca entre os diferentes profissionais e as decisões que se dão de maneira mais integrada do que no multiprofissional:

> *O interdisciplinar [...] que exista ali uma horizontalidade maior, de fato discutir, decidir coisas juntos. Condutas,*

direcionamentos dos tratamentos e acho que em Saúde Mental precisa ser pelo menos dessa forma [...] A proposta interdisciplinar parece, para mim, mais próxima do possível [...] porque as pessoas vão poder manter de alguma forma a sua especificidade. (E1)

♦ Trabalho em equipe transprofissional em Saúde Mental

Seis profissionais se aproximaram do conceito de trabalho transprofissional, dos quais três trabalhavam no CECCO. Destacaram a dissolução das fronteiras entre as especialidades e desafios de operar esta modalidade no cotidiano:

[...] é algo que vai além do inter, uma proposta que fico muito na dúvida onde que vai entrar ali o específico mesmo. [...] É algo [...] abstrato, acho que é pouco palpável[...]" (E1).

[...]existe uma maleabilidade maior nesta composição [...] Na nossa atuação profissional, a gente percebe os limites, mas estes limites não são muito definidos, muito determinados. (E6)

♦♦ Categoria 2 - Percepções a respeito do trabalho em equipe multiprofissional, interprofissional e transprofissional nas unidades em que atuavam

Os entrevistados responderam se o trabalho em equipe se dava de maneira multi, inter ou transprofissional nos serviços e os fatores considerados prejudiciais para a integração disciplinar: centralidade das ações na figura do médico; ausência de profissionais e de formação adequada; falta de condições institucionais e de infraestrutura física e dificuldade de integração dos diferentes saberes na prática em equipe. Falaram sobre fatores que favorecem tais práticas e da potência destas no cuidado dos usuários, bem como sobre o conceito de Projeto Terapêutico Singular (PTS). Serão tratados apenas os aspectos mais relevantes desta categoria.

♦ Percepção dos entrevistados quanto ao trabalho nos serviços nas funções multi, inter ou transprofissional

No CAPS, dois profissionais consideraram o trabalho como multiprofissional. Referiram não ter clareza nos conceitos de inter e transprofissionalidade. Outros dois entrevistados referiram que o trabalho ocorria de modo interdisciplinar. No CECCO, para um dos profissionais o trabalho era multiprofissional, enquanto os outros três referiram ser transdisciplinar. No ambulatório, um dos profissionais considerou o trabalho multiprofissional, enquanto outros dois disseram que atualmente não há trabalho multi, inter ou transprofissional, que acontecia apenas com a inserção da Residência naquele campo.

Três entrevistados consideraram que o trabalho se dava de maneira multiprofissional nos serviços de Saúde Mental em que atuavam:

As decisões são, em sua maioria, tomadas em equipe, as pessoas se complementam, trabalham em torno de um mesmo caso, temos vários espaços de discussão [...] Tem certa homogeneização [...] O serviço precisa disso [...] Quando tem essas questões de pessoas que por algum motivo não compõem, a gente tenta atenuar, tenta cuidar disso. (E10)

Três entrevistados consideraram o trabalho interprofissional em seus equipamentos:

O trabalho aqui é multiprofissional, mas nessa linha que é interdisciplinar [...] Nos momentos de supervisão, onde é preconizado que tenha uma dupla de profissionais de áreas diferentes; seja nas intervenções em grupos onde, dentro do possível, se preconiza que tenha uma coterapia de diferentes áreas. As famílias acabam sendo maior referência do atendimento interdisciplinar aqui do CAPS. [...] O espaço da supervisão é o espaço que faz esse exercício [...] todos os profissionais têm seu espaço para ser discutido, quando estão com pouco espaço são convocados a ocupar este espaço, de que a gente torne aquilo o mais igualitário possível. (E5)

Três entrevistados perceberam o trabalho como transdisciplinar, sendo todos do CECCO:

O transdisciplinar é muito mais próximo, acho que é a maneira como a gente trabalha aqui no CECCO, que é esta evolução de ir e vir no caso com os nossos saberes, com a nossas técnicas [...] estar transitando e compartilhando o saber específico, mas, ao mesmo tempo, mantendo a visão global do frequentador [...] Não é que seja exclusivo do CECCO a transdisciplinaridade, é que, pelos lugares onde trabalhei, o local onde encontrei mais forte [...] foi aqui[...] (E6)

Dois entrevistados apontaram para a não existência de trabalho multi, inter ou transprofissional no ambulatório, que aconteceu apenas durante a inserção dos alunos da Residência Multiprofissional naquele campo:

A gente não tem isto, porque hoje a assistência[...] com a perda da Residência, dos estagiários de Medicina e da Terapia Ocupacional e da Residência Multi, acho que tem aí uma falha, uma ausência de assistência multi, hoje a gente tem basicamente só assistência da Psiquiatria. Por conta dessa ausência de profissionais. (E11)

♦ Fatores que interferem negativamente na prática multi, inter e transprofissional nas unidades em que os entrevistados atuavam

Todos os entrevistados apontaram centralidade das ações na figura do médico nos serviços em que atuavam. Ressaltaram a importância da horizontalidade das relações para pensar em trabalho multi, inter ou transprofissional.

> *O trabalho é numa equipe horizontal. [...] Todo mundo trabalhando junto, não é hierarquizado [...] Uma área que acaba se sobressaindo [...] é a área médica. Seria mentira dizer que não, demagógico, porque [...] não tem supervisão sem um médico [...] o CAPS não pode ficar sem médico. Acho que como é um serviço de saúde ele acaba sim tendo uma certa diferença em relação ao papel do médico, mas acho que aqui isso é extremamente atenuado, especialmente pensando que a gente está numa escola médica [...] Não são questões ideológicas, são questões de necessidade [...].* (E10)

> *Todo mundo receber a mesma coisa pelas funções. No que diz respeito aos médicos, isso é mais complicado [...] Vencer esta barreira, acho que é utópico o que vou falar, se tratando de uma escola de Medicina, acho que isso é uma premissa, arraigado, mas acho que esse modelo medicocêntrico, da supremacia médica, desse saber [...] O tratamento pode ser algo mais amplo, as coisas não precisam ser excludentes, podem ser complementares. Acho que isso é um grande entrave [...] é um desafio e a gente consegue muito aqui, de não ser algo centrado, mas é o que te falei, acho que é algo que vem de formação, da faculdade [...]* (E11)

Oito profissionais destacaram as dificuldades cotidianas de integrar os diferentes saberes e fazer com que se reflitam em ação conjunta ao usuário:

> *Aqui e em qualquer lugar, é que o multi não seja um monte de coisas diferentes, que o multi seja o diálogo e a integração, para que a gente possa convergir o saber de cada um e a formação e a especificidade em projetos terapêuticos, em projetos de oficinas[...]* (E3)

♦ Potencialidades percebidas na prática multi, inter e transprofissional

Sete profissionais destacaram a relevância das práticas multi, inter e transprofissionais no cuidado ao usuário dos serviços.

> *De acordo com a política atual de Saúde Mental, existe o reconhecimento da necessidade de vários olhares para essa questão [...] Além de contribuir para a gente poder fazer um diagnóstico mais amplo, poder pensar em condutas variadas, acho que trabalhar em equipe é um modo de, não só de dividir o trabalho, mas de construir mesmo algo que seja o mais[...] completo possível.* (E1)

> *Acho que é a única forma de dar conta de um objeto tão complexo que é o cuidado em Saúde Mental, tanto na promoção quanto na prevenção[...] Entender o sujeito humano[...] As relações, acho que sozinha nenhuma área pode muito[...] Todas podem um pouco, todas juntas podem um pouco mais.* (E3)

Nove entrevistados falaram sobre características dos equipamentos em que atuavam que podiam favorecer o trabalho multi, inter ou transprofissional. Destacaram a abertura ao diálogo e a ação conjunta das pessoas nas equipes, garantia de espaços de discussão e estudo, referenciais teóricos comuns e a experiência e comprometimento dos profissionais com sua prática.

♦ Categoria 3 - Percepções sobre o trabalho desenvolvido pelos residentes da Residência Multiprofissional em Saúde Mental da UNIFESP

Os entrevistados responderam sobre as potencialidades do Programa, os desafios percebidos neste e também a respeito do projeto pedagógico- assistencial para atuação dos alunos. Dentre as potencialidades, citou-se a troca de conhecimentos que a inserção dos residentes permitia e a motivação e boa formação dos alunos. O pouco tempo em cada campo de estágio e as dificuldades de interação com a equipe fixa foram destacados como desafios.

Todos os entrevistados observaram a importância da atuação da Residência em suas unidades de trabalho, valorizada a possibilidade de trocas mútuas que se instalava com a chegada dos residentes.

Sete profissionais consideraram pouco o tempo de estágio dos residentes nos serviços de Saúde Mental, especialmente os do CECCO e do CAPS. Todos os entrevistados consideraram a interação dos residentes com as equipes fixas dos serviços de Saúde como desafio. Destacaram alunos mais disponíveis do que outros e o pouco tempo somado à rotina do serviço como dificultadores deste processo.

Segundo alguns entrevistados, eram os residentes que traziam para o equipamento a demanda de produção de cuidado em rede, nem sempre existente nos serviços universitários da UNIFESP e central para as propostas de Reforma Sanitária e Psiquiátrica.

DISCUSSÃO

Ações de integração disciplinar tiveram origem na necessidade de incorporar

diferentes práticas na assistência em Saúde, pela nova concepção do processo saúde-doença (OMS), que incorporou dimensões sócio- culturais e coletivas.[13]

Ao definir as diferentes modalidades de integração disciplinar, a maioria percebeu que na multidisciplinaridade, apesar da existência de um sentido conjunto, ainda há fragmentação da atenção ofertada aos usuários dos serviços, pois não ocorriam necessariamente trocas entre os profissionais. Mesmo com intervenções conjuntas, estas se davam na lógica de que cada profissional mantém seu modo específico de pensar e agir, o que compartimentaliza o atendimento.

As definições de trabalho multiprofissional se aproximam da noção de equipe agrupamento [11], caracterizada por fragmentação da atenção e justaposição das ações de Saúde e de maior clareza entre as fronteiras de cada especificidade profissional. Também se aproximam de ações em que há ajuda entre os profissionais, sem construção conjunta de planos terapêuticos.

Como percebido pela maioria dos entrevistados, no trabalho interprofissional há aproximação da ideia de compartilhar. Neste se dá um passo além do trabalho conjunto (apontado nas práticas multiprofissionais), na direção daquilo que é compartilhado, com maior horizontalidade, discussão e decisões conjuntas. Diferentemente das definições sobre trabalho multiprofissional, ao falar do inter, os trabalhadores usaram termos como “trocas”, “compor com o outro”, “ações conjuntas e comuns”, “mistura” e “somatória”, no sentido de indicar que nesta modalidade há maior integração entre os diferentes saberes; também, é possível dizer que há maior chance de trabalho como equipe integração [11], pois a articulação entre seus membros se dá de maneira mais efetiva e as fronteiras de cada especialidade se flexibilizam.

O trabalho interprofissional, ao estabelecer conexões entre diferentes áreas, parece ser a única forma de se aproximar dos objetivos da Reforma Psiquiátrica[14], que propõe novas maneiras de trabalho em equipe, visando a transversalidade entre sujeitos, o respeito e valorização de saber fazer das diferentes formações e a coresponsabilização da atenção a cada usuário [6].

Ao considerar que o trabalho se dava nas perspectivas de integração disciplinar, a maioria dos entrevistados justificou a partir de reuniões, supervisões e discussões de caso em equipe multiprofissional no cotidiano dos equipamentos. Apesar de serem ferramentas centrais para organização do trabalho em equipe multiprofissional, e os dispositivos periódicos em que este pode se dar, vale a pena destacar que apenas a configuração de tais espaços não parece dar conta de que as práticas do serviço sejam efetivamente multi, inter ou transprofissionais.

Sobre as respostas que apontaram não haver trabalho multi, inter ou transprofissional no ambulatório, destacou-se que a integração disciplinar foi possível apenas durante o ano em que a Residência esteve presente no serviço, pois após a assistência foi apenas psiquiátrica. Tal colocação se relaciona com a ausência de profissionais não-médicos no equipamento, o que levanta a questão sobre se é possível formar residentes em perspectiva multiprofissional onde não há equipe composta por diferentes especialidades. Parece-nos certa perversão da proposta das Residências Multiprofissionais que serviço formador precise dos residentes para funcionar de maneira multidisciplinar. Como pode a educação oferecida em serviço cuja assistência se dá no viés da Psiquiatria, e não da Atenção Psicossocial, se aproximar das concepções das Residências Multiprofissionais em Saúde Mental? Como é possível se conectar com as propostas da Reforma Psiquiátrica e do SUS estando em serviço distanciado destas? Estes questionamentos se colocam para outros ambulatórios que compunham a grade dos residentes.

Destacamos que as propostas de integração disciplinar buscam igualdade de condições das diferentes profissões, que passam a ter, idealmente, a mesma responsabilidade pelos usuários dos serviços de Saúde Mental, onde os diversos saberes têm o mesmo peso e os PTS são construídos em conjunto.[14] Sobre a centralidade das ações na figura do médico, não nos parece possível separar ideologia de necessidade, de maneira que a ideia de que o serviço de Saúde Mental não possa funcionar sem a presença do médico traz influências do modo de pensar o sujeito e os transtornos mentais, herança das práticas manicomiais.

Para a maioria dos entrevistados de nosso estudo, a integração disciplinar ainda se mostrou um desafio, especialmente no tocante aos diferentes saberes poderem significar ação efetivamente conjunta em prol do usuário. Os profissionais apontaram como barreiras a pouca resolutividade das equipes, a importância do multi não significar monte de propostas diferentes, mas integração efetiva; o foco do tratamento, neste mesmo sentido; e a chegada ao concílio. A partir da literatura[15], podemos relacionar tais percepções com os diferentes valores

desenvolvidos historicamente por especialidade, formações com ênfases diversas e também às dificuldades de comunicação. Pode acontecer de cada um cumprir sua função sem pensar na inserção grupal, o que gera conflitos e desorganização, a configurar o "trabalho em linha de montagem". [15] Tal caracterização se torna crítica ao processo de trabalho em equipe, que, apesar de se inserir numa perspectiva integral, acaba por ficar fragmentado. A diferenciar a prática da idealização, percebe-se que muitos serviços se dizem multi ou interprofissionais, no entanto, pode ser apenas que ali trabalhem diferentes especialidades.

As práticas multi e interprofissionais são entendidas na literatura[10,14] como centrais para que as propostas da Reforma Psiquiátrica se tornem realidade, o que, a nosso ver, fala também do caráter político deste agir profissional. Político no sentido de que a teoria e a prática em Saúde Mental, pensadas no contexto proposto pela Reforma Psiquiátrica, propõem o debate constante sobre o mundo e a vida que se almeja.[10] Tal dimensão não apareceu nas respostas dos entrevistados, que se voltaram mais à prática clínica propriamente dita.

Os apontamentos a partir das falas dos entrevistados podem ser também ampliados para a atuação dos residentes multiprofissionais, especialmente no que diz respeito às restritas discussões sobre os conceitos de multi, inter e transdisciplinaridade, pouco trabalhados nos dois anos de formação no referido Programa, e à reduzida articulação direta com as políticas públicas e a atuação política dos trabalhadores de Saúde Mental e residentes.

Questionamos o quanto a atuação dos residentes pode acabar apenas se voltando aos aspectos clínicos da condução dos casos, o que se relaciona com a formação recebida e as ideologias de quem ensina. Ensino, idealmente, é ação contraditória, política e que transmite valores sociais, processo que ocorre com conflitos e dificuldades, aproveitados para transformação e construção das Residências Multiprofissionais.[16]

Ao pensarmos no histórico de formação médica da UNIFESP, verificamos o quanto a formação despolitizada e voltada essencialmente à clínica *strictu sensu* e a hegemonia da prática médica ainda se mostraram presentes na Residência Multiprofissional, herdeira também do modelo de formação das especializações em Saúde, especificamente em Saúde Mental, nesta Universidade. [10, 17]

A Residência Multiprofissional da UNIFESP vem de encontro ao proposto pelas Políticas Públicas de Saúde. Apesar de coordenadores e docentes não médicos, há pouca problematização dos conceitos de multi e interprofissionalidade e a prática dos residentes acaba por ser aproximar da interdisciplinaridade auxiliar.[1,3] Diante das barreiras colocadas aos residentes em questionar o poder médico, este continua se posicionando como coordenador do cuidado em Saúde Mental, a afastar das propostas de horizontalização do saber e integralidade do cuidado, centrais para a Reforma Psiquiátrica.

Sobre o alinhamento de referenciais teóricos, citado especialmente quando referidos à Psicanálise/ Psicodinâmica (linha de escolha do CAPS e de outros serviços que compõem a grade da Residência Multiprofissional em Saúde Mental da UNIFESP), nos perguntamos se o serviço psicanalítico (ou psiquiátrico, comportamental, etc.), de fato pode dizer respeito às práticas interprofissionais, na medida em que o interdisciplinar preza pela integração de diferentes saberes, o que não se coloca na homogeneidade de um mesmo discurso teórico.

Especificamente na Saúde Mental, a questão da formação ainda é um dos grandes desafios para a efetiva implantação da Reforma Psiquiátrica[18], o que vai ao encontro do proposto[19] como politização na formação em serviço, esta, como a tendência educativa para formação de residentes, capaz de instaurar novas maneiras de cuidado e organização do processo de trabalho.

Apesar de não citado pelos entrevistados, a principal potência da Residência Multiprofissional em Saúde Mental diz respeito à possibilidade da formação engajada com os pressupostos da Reforma Psiquiátrica e do SUS, à formação de trabalhadores-cidadãos, com perfil à atuação também política em sua prática. Espera-se destes a visão de saúde ampliada e integral, com ações humanistas, democráticas e críticas da realidade, alinhadas às ações antimanicomiais.[19]

Destacam-se como principais características das Residências Multiprofissionais a desterritorização dos saberes e descentralização das práticas[18], pelas atividades previstas para os residentes não os inserirem apenas em serviços substitutivos, também incentivarem a visão global e crítica da rede como um todo.

É importante valorizar o papel dos residentes, ao mesmo tempo profissionais e estudantes, como ocupantes de um "não lugar" privilegiado, capaz de produzir

mudanças no instituído e de criação de instituintes no campo da Saúde, bem como de relevância no estreitamento de vínculos entre os trabalhadores, usuários dos serviços de Saúde e a comunidade. [20]

Apesar da maioria dos profissionais considerarem suas práticas como multi ou interprofissionais, a hierarquia médica e a verticalização das relações ainda eram realidades nos equipamentos ligados ao Departamento de Psiquiatria da UNIFESP, o que comprometeu a integração disciplinar efetiva. Os profissionais associaram multi e interdisciplinaridade à realização de reuniões e discussões de caso em equipe, o que não necessariamente mostra a existência de objetivos e ações compartilhados, características intrínsecas às ações interprofissionais.

Além da herança das especializações profissionais oferecidas anteriormente ao Programa de Residência Multiprofissional, este ainda parece se dar de maneira similar à Residência Médica em Psiquiatria da UNIFESP.

Apesar da pouca integração, corroborada pelo Ministério da Educação ao instituir duas residências separadas, quando os residentes multiprofissionais e médicos tinham atividades compartilhadas, estas se estruturaram em torno do saber da Medicina. Além disto, a formação dos residentes multiprofissionais se dá centrada no modelo de assistência das unidades formadoras, que nem sempre se alinham às Políticas Públicas de Saúde, ao não se articularem com a rede do SUS.

CONCLUSÃO

Acredita-se que seja fundamental reaproximar a Residência Multiprofissional em Saúde Mental da UNIFESP das políticas públicas em Saúde e do que prevê a legislação desta modalidade de especialização, o que poderia ser feito a partir da maior participação dos residentes do Programa em serviços que componham a Rede de Atenção Psicossocial do município de São Paulo/SP, em detrimento daqueles ligados ao Departamento de Psiquiatria da UNIFESP. Outra possibilidade de aproximação das propostas do SUS nos parece ser o envolvimento com serviços focados na prevenção e promoção de saúde, como Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASFs), a resgatar a importância da integralidade nos modelos de atenção em Saúde de nosso País.

Merece destaque também a consideração de que os desafios apontados neste estudo não parecem ser exclusivos da Residência Multiprofissional em Saúde Mental em questão, mas podem dialogar com dificuldades vivenciadas em todo o País, tanto no que diz respeito aos equipamentos de Saúde Mental, quanto da modalidade de formação em serviço, proposta pelas Residências Multiprofissionais. As críticas e problematizações aqui apresentadas apontam para a necessidade de mais discussões e espaços para o repensar das práticas, seja dos profissionais que se dedicam há mais tempo ao campo da Saúde Mental, quanto dos que deste se aproximaram recentemente.

REFERÊNCIAS

1. Tavares CMM. Interdisciplinarity as requisite for the formation of the psychiatric nurse in the perspective of psycho-social care. Texto & contexto enferm [Internet]. 2005 July/Sept [cited 2016 Feb 23];14(3):403-10. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072005000300012 doi: 10.1590/S0104-07072005000300012

2. Japiassu H. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago; 1976.

3. Costa RP. Interdisciplinarity and health staffs: conceptions. Mental [Internet]. 2007 June [cited 2016 Feb 23];8:107-24. Available from: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-44272007000100008 ISSN 1679-4427.

4. Hamel G, Prahalad CK. Competindo pelo futuro: estratégias inovadoras para obter o controle do seu setor e criar os mercados de amanhã. Rio de Janeiro: Campus; 1995.

5. Nicolescu B, Morin E, Freitas L (Comitê de Redação). Carta da Transdisciplinaridade: Artigo 3º. Primeiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade. Convento de Arrábida, Portugal, 1994.

6. Assega ML, Lopes- Júnior LC, Assega DT, Lima RAG, Pirolo SM. Singular therapeutic project and multiprofessional team in clinical complex case management: an experience report. J Nurs UFPE on line [Internet]. 2010 Apr [cited 2016 Feb 23];9(4):7482-8. Available from: http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/viewFile/7074/pdf_7597 doi: 10.5205/reuol.7275-62744-1-SM.0904201537

7. Furtado JP, Campos RO. The transposition of mental health policies in Brazil to practice in new services. Rev latinoam psicopatol fundam [Internet]. 2005 mar [cited 2016 Feb 23];8(1):109-22. Available from: http://www.redalyc.org/pdf/2330/233017514011.pdf ISSN: 1415-4714

8. Brasil. Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília. 1990 set. 20; Edição n. 182, Seção 1, p. 1

9. Brasil. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria Interministerial n. 1077, 12 de novembro de 2009. Dispõe sobre a Residência Multiprofissional em Saúde e a Residência em Área Profissional da Saúde, e institui o Programa Nacional de Bolsas para Residências Multiprofissionais e em Área Profissional da Saúde e a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde. Diário Oficial da União, Brasília. 2009 nov. 13;Seção 1. P. 7

10. Nascimento DDG, Oliveira MAC. Professional competences and the training process in a multi-professional internship in Family Health. Saúde Soc [Internet]. 2010 [cited 2016 Feb 23];19(4):814-27. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902010000400009 doi: 10.1590/S0104-12902010000400009

11. Peduzzi M. Multiprofessional healthcare team: concept and tipology. Rev Saúde Públ. 2001 [cited 2016 Feb 23];1(35):103-9. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-89102001000100016&script=sci_abstract&tlng=pt doi: 10.1590/S0034-89102001000100016

12. Bardin L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70; 1977.

13. Boccardo AC, Zane FC, Rodrigues S, Mângia EF. The singular therapeutic project as a strategy of organization for care in mental health services. Ter Ocup Univ São Paulo [Internet]. 2011 Jan/Apr [cited 2016 Feb 23];22(1):85-92. Available from: http://www.revistas.usp.br/rto/article/view/14124 doi: 10.11606/issn.2238-6149.v22i1p85-92

14. Antunes SMMO, Queiroz MS. Psychiatric reform in a local context in Brazil: a qualitative analysis. Cad Saúde Pública [Internet]. 2007 Jan [cited 2016 Feb 23];23(1):207-15. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2007000100022 doi: 10.1590/S0102-311X2007000100022

15. Ferreira RC, Varga CRR, Silva RF. Working in multiprofessional teams: the perspectives of family health residentes. Ciênc e saúde colet [Internet]. 2009 [cited 2016 Feb 23];14(1):1421-28. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232009000800015 doi: 10.1590/S1413-81232009000800015

16. Ferreira SR, Olschowsky A. Integrated Residence in health: the integration among different areas from knowledge. Rev Gaúcha Enferm [Internet]. 2009 Mar [cited 2016 Feb 23];30(1):106-12. Available from: http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/23621

17. Lima M, Santos L. Education for psychologists in multi-professional residencies: transdisciplinarity, professional body, and mental health. Psicol, Ciênc Prof [Internet]. 2012 [cited 2016 Feb 23];32(1):126-41. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932012000100010 doi: 10.1590/S1414-98932012000100010

18. Lobosque AM. A experience of Multiprofesional Residence in Mental Health: deterritorializing knowledges, decentralizing practices. Cad Bras Saúde Ment/Brazilian Journal of Mental Health [Internet]. 2012 [cited 2016 Feb 23];4(10):197-200. Available from: http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/cbsm/article/view/2357

19. Jesus ML, Araujo D. Politicization and education in service: meaning and sense attributed by residents in a multi-professional residency program in mental health in the State of Bahia. Psicol, Teor Prát [Internet]. 2011 [cited 2016 Feb 23];13(3):67-80. Available from: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-36872011000300006 ISSN 1516-3687

20. Carneiro AC, Oliveira ACM, Santos MMS, Alves, MS, Casais NA, Santos AS. Popular Education in Mental Health: experience report. Saúde Soc [Internet]. 2010 [cited 2016 Feb 23];19(2):463-74. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-12902010000200021&script=sciabstract&tlng=pt doi: 10.1590/S0104-12902010000200021.

Submissão: 01/10/2016
Aceito: 31/12/2016
Publicado: 01/02/2017

Correspondência

João Fernando Marcolan
Rua Napoleão de Barros, 754
Bairro Vila Clementino
CEP: 04024-002 — São Paulo (SP), Brasil